



Герпес-вирусная инфекция в дерматологии: проблемы и современный подход к лечению

Авторы:

Кунгуров Н.В., Кохан М.М., Кениксфест Ю.В., Бакуров Е.В., Пазина М.В.

Подробнее об авторах

Журнал: Клиническая дерматология и венерология. 2015;14(5): 117-124

DOI: 10.17116/klinderma2015145117-124

Прочитано: 10786 раз

[Скачать PDF](#)

[Связаться с автором](#)



[Оглавление](#)

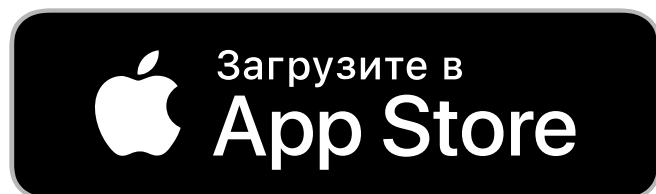




Пазина М.В. Герпес-вирусная инфекция в дерматологии: проблемы и современный подход к лечению. *Клиническая дерматология и венерология*. 2015;14(5):117-124.

Kungurov NV, Kokhan MM, Keniksfest IuV, Bakurov EV, Pazina MV. Herpes virus infection in dermatology: problems and modern approach to treatment. *Russian Journal of Clinical Dermatology and Venereology*. 2015;14(5):117-124. (In Russ.)

<https://doi.org/10.17116/klinderma2015145117-124>



Заккрыть метаданные

Рекомендуем статьи по данной теме:

Клинический случай неэффективности терапии инфекции, вызванной *Mycoplasma genitalium*. *Клиническая дерматология и венерология*. 2026;(1):31-35

Современные и перспективные методы лечения постгерпетической невралгии. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. 2025;(4):27-34

Когнитивные нарушения у пациентов с рассеянным склерозом. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски*. 2025;(4-2):67-73

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ 2024). Клинические рекомендации (краткая версия). *Респираторная медицина*. 2025;(2):5-16

Внебольничная пневмония у взрослых. Клинические рекомендации 2024 (краткая версия). *Респираторная*



Поиск факторов риска замедления внутрисердечной проводимости у пациентов с шизофренией. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2025;(11):111-116

Эффективность и безопасность препарата Авиандр в терапии панического расстройства: результаты первого периода многоцентрового рандомизированного плацебо-контролируемого исследования. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2025;(12):161-171

Абдоминальная псевдогрыжа: причины возникновения и хирургическая тактика. Эндоскопическая хирургия. 2026;(1):45-53

Согласованное мнение экспертов Российского кардиологического общества, Российской ассоциации эндокринологов и Ассоциации флебологов России в отношении приверженности к терапии хронических заболеваний*. Флебология. 2026;(1):6-14

Резюме / Abstract:

Представлены современные данные литературы об особенностях клинических проявлений герпесвирусной инфекции в дерматологии: рецидивирующего фациального и лабиального герпеса, опоясывающего лишая, герпетической экземы, герпес-вирусассоциированной полиморфной экссудативной эритемы. Изложены основные принципы и схемы противовирусной терапии, представлен собственный опыт эффективной терапии заболеваний, вызванных вирусом простого герпеса, препаратом валацикловира (Валвир).

Ключевые слова / Keywords:

вирус простого герпеса 1-го и 2-го типов

рецидивирующий фациальный герпес

лабиальный герпес

опоясывающий лишай

герпетическая экзема

полиморфная экссудативная эритема

терапия

валацикловир

Валвир



УрНИИДВиИ

Кохан М.М.

Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии Минздравсоцразвития России, Екатеринбург

Кениксфест Ю.В.

ФГУ Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии Минздравсоцразвития РФ, Екатеринбург

Бакуров Е.В.

ФГБУ «Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии» Минздрава России, Екатеринбург, Россия, 620076

Пазина М.В.

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» Минздрава России, Екатеринбург, Россия, 620076

Рецидивирующие формы...

Герпетиформная экзема...

Герпес и поли



распространена в человеческой популяции в связи с пантропностью вирусов и их высокой инвазивностью [1, 2]. Среди всех герпес-вирусов наиболее часто встречаются члены подсемейства *Alphaherpesvirinae*: вирус простого герпеса 1-го и 2-го типов (ВПГ-1 и ВПГ-2; *Herpes simplex virus-1* и *Herpes simplex virus-2*), вызывающие фациальные (лабиальные, орофациальные) и генитальные поражения кожи и слизистых, а также вирус *Varicella zoster* (*Human herpesvirus-3*), являющийся этиологическим фактором ветряной оспы и опоясывающего лишая [2–4].

По данным ВОЗ, до 95% жителей планеты инфицированы ВПГ-1 и ВПГ-2, причем имеющиеся данные указывают на прогрессирующий рост заболеваемости в большинстве стран Европы и Америки, опережающий темпы прироста населения. Эпидемиологические и серологические исследования показывают, что распространенность инфицированности ВПГ-2 в мире достигает 400 млн человек, из них около 267 млн женщин и до 150 млн мужчин [3].

В прошлом существовало мнение об избирательном поражении ВПГ-1 исключительно области лица, а ВПГ-2 — наружных половых органов, однако в последние десятилетия были получены новые данные: ВПГ-1 вызывает оролабиальный герпес лица в 80–90% случаев, а ВПГ-2 — в 10–20%. Результаты проведенных исследований показали, что к 18 годам более 90% жителей городов инфицируются одним или несколькими штаммами вируса герпеса [1].

Пациенты с кожными проявлениями герпетической инфекции часто встречаются в практике дерматовенеролога, при этом основными нозологическими формами являются простой герпес кожи и слизистых, в том числе и с рецидивирующим течением; опоясывающий лишай, вызванный вирусом герпес зостер; реже — вирусные осложнения у больных атопическим дерматитом и другими дерматозами, именуемые герпетиформная экзема Капоши или варицеллеформный пустулез, острый оспенновидный пустулез Юлиусберга.

Рецидивирующие формы лабиального герпеса

Рецидивирующими формами герпеса страдают от 10 до 20% населения, а ежегодный прирост составляет 15–17%. По данным зарубежных исследований [5, 6], только у 20% инфицированных вирусом герпеса установлено это заболевание, у 60%, несмотря



по данным Э. Кетте и соавт. [6], рецидивирующий простой герпес (РПГ) встречается у 57,7% пациентов, инфицированных ВПГ в возрасте 14–49 лет. Большинство пациентов с РПГ имеют менее двух эпизодов в год, но у 5–10% больных высыпания рецидивируют более 6 раз в год. Частые рецидивы герпетических высыпаний на коже лица и шеи, боль, зуд, ознобы и слабость в продромальном периоде снижают качество жизни пациентов с РПГ. При проведении параллельного наблюдательного исследования у больных РПГ в США и Франции установлено, что при возникновении в течение года не более чем четырех эпизодов РПГ 67,0–68,0% больных отмечали снижение параметров качества жизни, а в подгруппах с более частым рецидивированием заболевания (6 раз год и более) такие изменения фиксировали уже 78,0–90,0% пациентов. Авторы [7] отмечают, что лечение по рекомендации врачей получают в США 63% пациентов с РПГ с обострениями более 6 раз в год, а во Франции — только 46,0%, остальные больные следуют советам фармацевтов или прибегают к самолечению.

Современные рекомендации по лечению РПГ с фациальной и лабиальной локализацией указывают на рациональность эпизодической терапии короткими курсами системными противовирусными препаратами и назначения пролонгированных курсов терапии (супрессивная терапия) при частоте рецидивов более 6 раз в течение 1 года [7, 8].

Герпетиформная экзема Капоши (варицеллеформный пустулез)

Герпетиформная экзема (ГЭ) — это диссеминированная ГВИ, вызванная ВПГ и осложняющая течение атопического дерматита (АтД) или экземы, а также буллезных хронических дерматозов, ожогов II–III степени тяжести, болезни Дарье, грибовидного микоза, синдрома Сезари [9, 10].

При ГЭ высыпания дебютируют в области кожи лица, но быстро диссеминируют, часто присоединяется пиодермия, нарушается общее состояние больных до среднетяжелого и тяжелого, развивается гипертермия, лимфаденопатия. ГЭ, как правило, возникает у пациентов с АтД в возрасте 10–30 лет преимущественно на фоне распространенного кожного процесса. Установлено, что ГЭ чаще развивается у больных, недостаточно активно и правильно лечившихся



Показано, что у ГЭ-позитивных больных АтД наблюдаются более значимые изменения в системном иммунитете, значимо высокое содержание в сыворотке крови иммуноглобулина Е, более супрессированы антимикробные пептиды эпидермиса [9, 10, 12].

Герпес и полиморфная экссудативная эритема

Полиморфная экссудативная эритема (ПЭЭ) — острое реактивное заболевание кожи и слизистых оболочек, развивающееся в ответ на действие инфекционных агентов (бактерии, грибы, вирусы), медикаментов (сульфаниламиды, пенициллины, барбитураты, аллопуринол, фенилбутазон), а также при системных аутоиммунных и онкогематологических заболеваниях. В последние годы обоснованно считают, что причиной части случаев ПЭЭ является персистирующая инфекция ВПГ, которая проявляется рецидивами лабиального герпеса, однако может быть бессимптомной. Подобные случаи выделены в особую разновидность заболевания и получили наименование герпес-ассоциированная ПЭЭ (НАЕМ, *herpes-associated erythema multiforme*). Доказательством этиологической роли ВПГ в ПЭЭ служит обнаружение ДНК ВПГ-1 и ВПГ-2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в биоптатах кожи у 60% из числа обследованных пациентов с НАЕМ, причем у 66,7% больных обнаружили ВПГ-1, у 27,8% — ВПГ-2, у 5,6% — оба типа вируса. Показано, что НАЕМ рецидивирует у 20–25% пациентов, при этом число рецидивов составляет от 4 до 24 в течение года [13–15]. Так, R. Osterne и соавт. [14] описывают случай рецидивирующей трижды в течение года НАЕМ у подростка, протекавшей с выраженным нарастанием тяжести процесса в отсутствии противовирусной терапии.

Герпес у спортсменов

Герпетическая инфекция кожи — частая проблема у спортсменов, в особенности в тех видах спорта, где присутствует тесный телесный контакт: у борцов — «*herpes gladiatorum*», у игроков в регби — «*herpes rugbiorum*». Баскетболисты, футболисты, а также лыжники и конькобежцы, подвергаясь воздействию низких температур и ультрафиолетового солнечного излучения, также составляют группу риска рецидивирующего лабиального герпеса [16]. ГВИ среди спортсменов занимает 4-е место по частоте встречаемости среди



в области туловища — 11,0—28,0% [17]. Течение ГВИ у спортсменов может быть рецидивирующим с легкой и умеренной тяжестью каждого эпизода, однако специалистами разработаны рекомендации по обязательному лечению заболевания с использованием системных противовирусных препаратов в различных режимах, в том числе для лечения эпизодов, а также профилактическое назначение противовирусных препаратов и длительная пролонгированная (супрессивная) терапия в течение всего соревновательного периода [18].

Опоясывающий герпес

Опоясывающий герпес (ОГ), или опоясывающий лишай — спорадическое заболевание, представляющее собой реактивацию латентной вирусной инфекции, вызванной вирусом герпеса 3-го типа, поражающее преимущественно кожный покров и нервную систему, в отдельных случаях — конъюнктиву и роговицу [19]. Заболеваемость О.Г. увеличивается среди лиц старших возрастных групп (после 60 лет), рецидивы заболевания возникают примерно у 5,0% переболевших, часто сопровождаются формированием постгерпетической нейропатии (ПГН). Риск возникновения ОГ увеличен у пациентов с хроническими заболеваниями, такими как ревматоидный артрит и другие аутоиммунные поражения, обструктивные заболевания легких, заболевания почек, сахарный диабет 1-го типа, лимфопролиферативные заболевания, причем сочетание нескольких факторов риска особенно значимы для пациентов более молодого возраста. Наиболее часто ОГ развивается у больных с онкопатологией, иммунокомпроментированных субъектов, инфицированных ВИЧ, пациентов, получающих системную иммунодепрессивную терапию [20]. Данные исследований показали, что среди дерматологических больных частота верификации ОГ (на 1000 пациенто-лет) составляет 8,03%, тогда как у больных раком и системной красной волчанкой — 11,7 и 15,2% соответственно. По данным S. Chen и соавт. [21], к числу контингента лиц с высоким риском развития ОГ относятся и больные псориазом, для которых характерны девиации клеточно-опосредованного и гуморального звеньев иммунитета, а также пациенты, использующие иммунодепрессивные и цитостатические препараты, фотохимиотерапию. Значимым является факт более частого развития ОГ у больных псориазом, получавших иммунодепрессивную терапию, с повышением показателя до 10,8%. Отмечено нарастание



достигает 15,4% [20—22]. В работе G. Shalom и соавт. [22] представлены результаты оценки риска развития ОГ у больных псориазом, получающих системную терапию. Авторы отмечают увеличение такого риска при сочетании генно-инженерных биологических препаратов с метотрексатом. Рекомендации по лечению ОГ у больных с другой патологией кожи однозначно указывают на необходимость проведения системной противовирусной терапии, с момента установления диагноза и желательно в первые 72 ч. Выбор противовирусного препарата и пути его введения, госпитальный или амбулаторный режим лечения, длительность терапии определяются клиническими особенностями процесса, тяжестью заболевания [23, 24].

Подходы к терапии герпес-вирусной инфекции кожи

В настоящее время для лечения больных ГВИ общепризнана необходимость противовирусной химиотерапии с использованием ациклических нуклеозидов — высокоспецифичных препаратов, обладающих доказанным противовирусным эффектом. В группу ациклических нуклеозидов входят ацикловир, валацикловир и фамцикловир. Первым из противовирусных препаратов был синтезирован ацикловир, модифицированный аналог компонента ДНК вируса. Для приобретения биологической активности в организме ацикловир проходит три этапа фосфорилирования, в результате которых образуется ацикловир-трифосфат, конкурентно подавляющий вирусную ДНК-полимеразу.

Однако недостатком ацикловира является низкая биодоступность и вытекающая отсюда необходимость многократного приема в течение суток — строго через каждые 4—5 ч. В поиске способов повышения биодоступности ацикловира был создан препарат валацикловир, представляющий собой L-валиновый эфир ацикловира. Валацикловир представляет собой «пролекарство», которое гидролизуется в кишечнике и печени под действием фермента валацикловир-гидролазы и освобождается от эфирной «надстройки», полностью (около 99%) превращаясь в ацикловир, который далее встраивается в полинуклеотидную цепочку ДНК вируса и блокирует дальнейшие удлинения молекулы ДНК. L-валиновый эфир повышает биодоступность препарата при приеме внутрь в 3,3—5,5 раза по сравнению с ацикловиром (биодоступность в зависимости от дозы



в сыворотке крови и других внутренних средах эквивалентны таковым при внутривенном введении ацикловира. Это позволяет уменьшить количество приемов препарата до 2 раз в день при рецидиве и до 1 раза в день — при супрессивной терапии (курс пролонгированной терапии), а также определяет возможность однодневной терапии большими дозами [24, 26].

Для этиотропной терапии герпетической инфекции используют следующие схемы назначения валацикловира:

- терапию первичной герпетической инфекции, направленную на купирование острых проявлений и предотвращение распространения процесса;
- терапию рецидива (эпизодическая терапия), позволяющую предупреждать рецидивы инфекции и купировать уже возникшее обострение;
- терапию межрецидивную, эпизодическую супрессивную (пролонгированную) терапию, проводимую для предотвращения рецидива при воздействии известного и ожидаемого триггера обострения ГВИ;
- терапию межрецидивную, профилактическую супрессивную длительную, назначаемую при крайне частых рецидивах заболевания, эффективно снижающую частоту рецидивов и предотвращающую передачу ВПГ партнеру;
- однодневную терапию, обеспечивающую радикальное купирование проявлений лабиального герпеса в течение 1 сут.

В последние годы, после завершения 30-летнего срока действия патента валацикловира (препарат валтрекс), на мировом фармацевтическом рынке появилось более 30 генерических препаратов валацикловира (в России таких препаратов 11). Из числа фармацевтических средств, действующим началом которых является валациклоvir, следует отметить препарат *Валвир* — аналог валацикловира (производство компании «Actavis», регистрационный №ЛП-001723 от 02.07.12).

Препарат *Валвир*, в отличие от оригинального валацикловира, выпускается в форме таблеток, покрытых пленочной кишечнорастворимой оболочкой, которая защищает действующее вещество от разрушения в кислой среде желудка. *Валвир* выпускается



Опыт лечения больных различными формами ГВИ кожи с использованием препарата *Валвир* (рис. 1, а, б; рис. 2, а, б; рис. 3, а, б; рис. 4, а, б).



Рис. 2. Опоясывающий герпес у больной В., 72 лет. До терапии — а и после лечения препаратом Валвир — б.

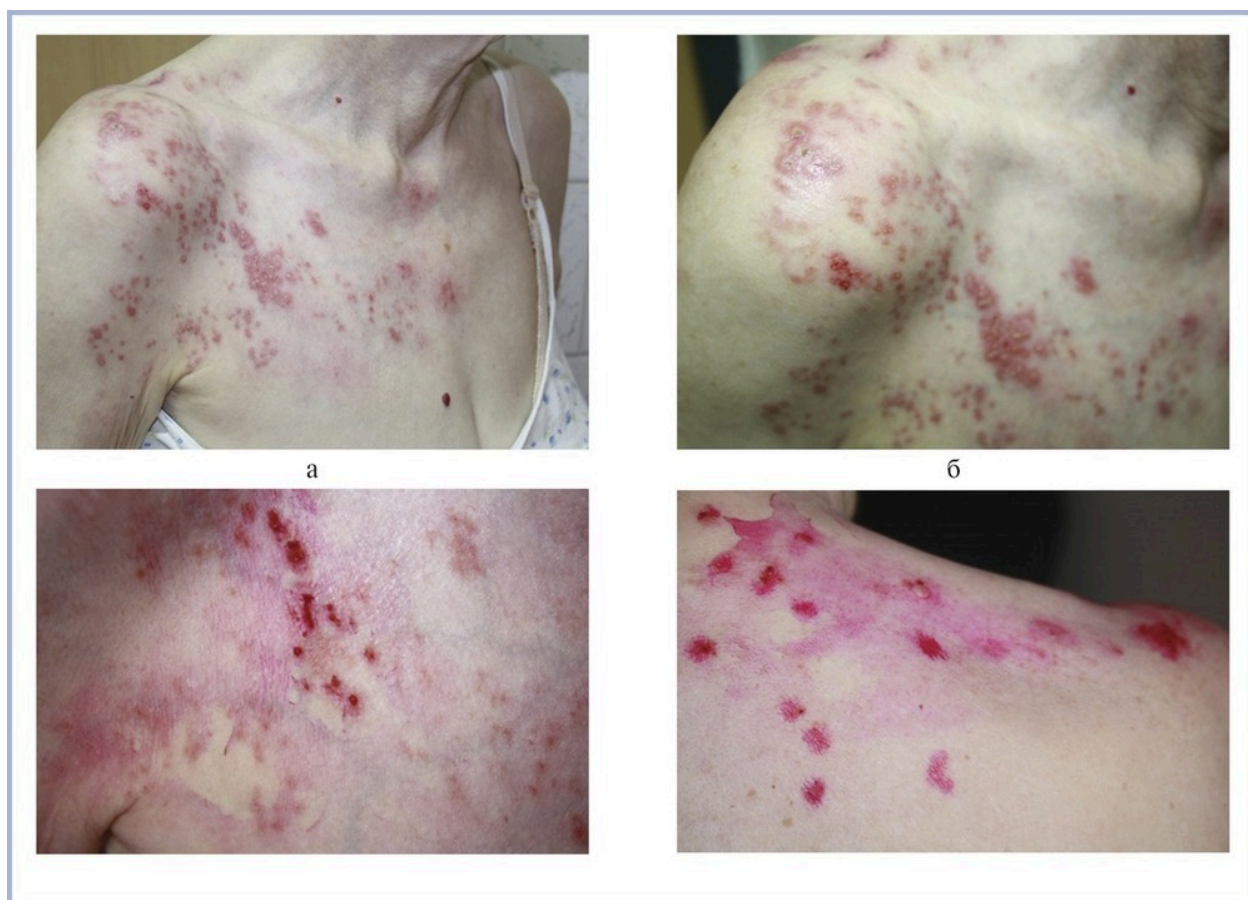




Рис. 4. Опоясывающий герпес у больной К., 58 лет. До лечения — а, б, в; после терапии препаратом Валвир — г, д, е.

В клинике ФГБУ «Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии» Минздрава России обобщен опыт лечения больных различными формами ГВИ кожи с использованием препарата *Валвир*. Под нашим наблюдением находились 17 пациентов (12 женщин и 5 мужчин) в возрасте от 16 до 83 лет с ГВИ кожи, из них 7 больных — с рецидивирующим лабиальным, фациальным герпесом, 1 пациент — с первичным аффектом лабиального герпеса; 6 — с ОГ, 2 — с АтД и герпетиформной экземой Капоши и 1 пациентка с рецидивирующей полиморфной экссудативной эритемой.

Клинико-анамнестические данные о группе пациентов с ГВИ представлены в табл. 1.



Герпес лабиальный, фа- циальный, рецидивиру- ющий	23—63	1/6	У 57,1% — до 3 рецидивов; у 42,8% — более 6 рецидивов	У 75% — после переохлаждения и/или ОРВИ; у 25% — без явных причин
Герпес лабиальный	22	1/0	Первичные проявления	Выраженный отек, гиперемия, везикулы на коже губы и угла рта
Герпес опоясывающий	43—83	1/5	У 66,7% — первичный эпизод; у 33,3% — 2 и 3 рецидива	33,3% больных имели в анамнезе ПГН
ГЭК	16—21	2/0	У всех первичный эпизод	Умеренная тяжесть процесса
ПЭЭ	27	0/1	3 рецидива в течение 12 мес	2 рецидива после перенесенного лабиального герпеса

Таблица 1. Клинико-анамнестические характеристики наблюдаемых больных с различными формами ГВИ кожи

Пациентам с РПГ (лабиальные, фациальные локализации) в случае умеренного количества рецидивов было назначено лечение препаратом *Валвир* в дозе 500 мг 2 раза в день в течение 5 дней, пациенту с выраженными первичными проявлениями герпеса (отек, гиперемия, везикулы на коже губы и в углах рта) была проведена однодневная экспресс-терапия в дозе 2000 мг, разделенные на 2 приема.

При ОГ пациентам назначали *Валвир* в дозе 1000 мг 3 раза в сутки в течение 7—14 дней, больным герпетиформной экземой — по 500 мг 2 раза в день в течение 7—10 дней. Лечение герпес-ассоциированной ПЭЭ проводили в режиме длительной супрессивной терапии по 500 мг в день в течение 4 мес. Все пациенты в процессе лечения и после его окончания находились под наблюдением, проходя ежемесячные клинические осмотры.

В табл. 2 представлены клинико-катамнестические данные результативности проведенной терапии.

Таблица 2. Эффективность терапии препаратом *Валвир* (на основании данных клинического мониторингирования больных ГВИ)

Диагноз	Срок исчезновения высыпаний, сут	Срок эпителизации эрозий, сут	Число рецидивов ГВИ за 6 мес	Клинические особенности
Герпес лабиальный, фа- циальный, рецидивирующий	2—3	До 5—7	У 3 больных рецидивов не было; у 3 больных по 1 реци- диву за 6 мес	Рецидивы клинически более легкие
Герпес лабиальный	2	6	Нет	Исчезновение боли, жжения, отека через 1 сут лечения
Герпес опоясывающий	5—6	7—9	У 5 из 6 больных рецидивов не было	Умеренная болезненность у всех больных, отсутствие ПГН
ГЭК	3	5—7	Нет	Отсутствие гипертермии с 3-го дня лечения
ПЭЭ	3	7	Нет	Уменьшение жжения и зуда после 3 сут лечения

Таблица 2. Эффективность терапии препаратом *Валвир* (на основании данных клинического мониторингирования больных



формами ГВИ, получавшими терапию препаратом *Валвир*, свидетельствуют о его высокой клинической эффективности: отмечалось быстрое купирование остроты процесса и эпителизации вторичных эрозивных проявлений, значимое уменьшение субъективных симптомов, а также отсутствие ПГН, уменьшение частоты и тяжести последующих рецидивов.

Клинические наблюдения

Больная С., 60 лет, с диагнозом: рецидивирующий простой герпес (рис. 1). Болеет в течение 3 лет, отмечает рецидивы ежемесячно. Методом ПЦР обнаружен ВПГ-1. Проведено лечение препаратом *Валвир* по 1000 мг в сутки в течение 5 дней. После курса лечения рецидивов в течение 6 мес не отмечали.

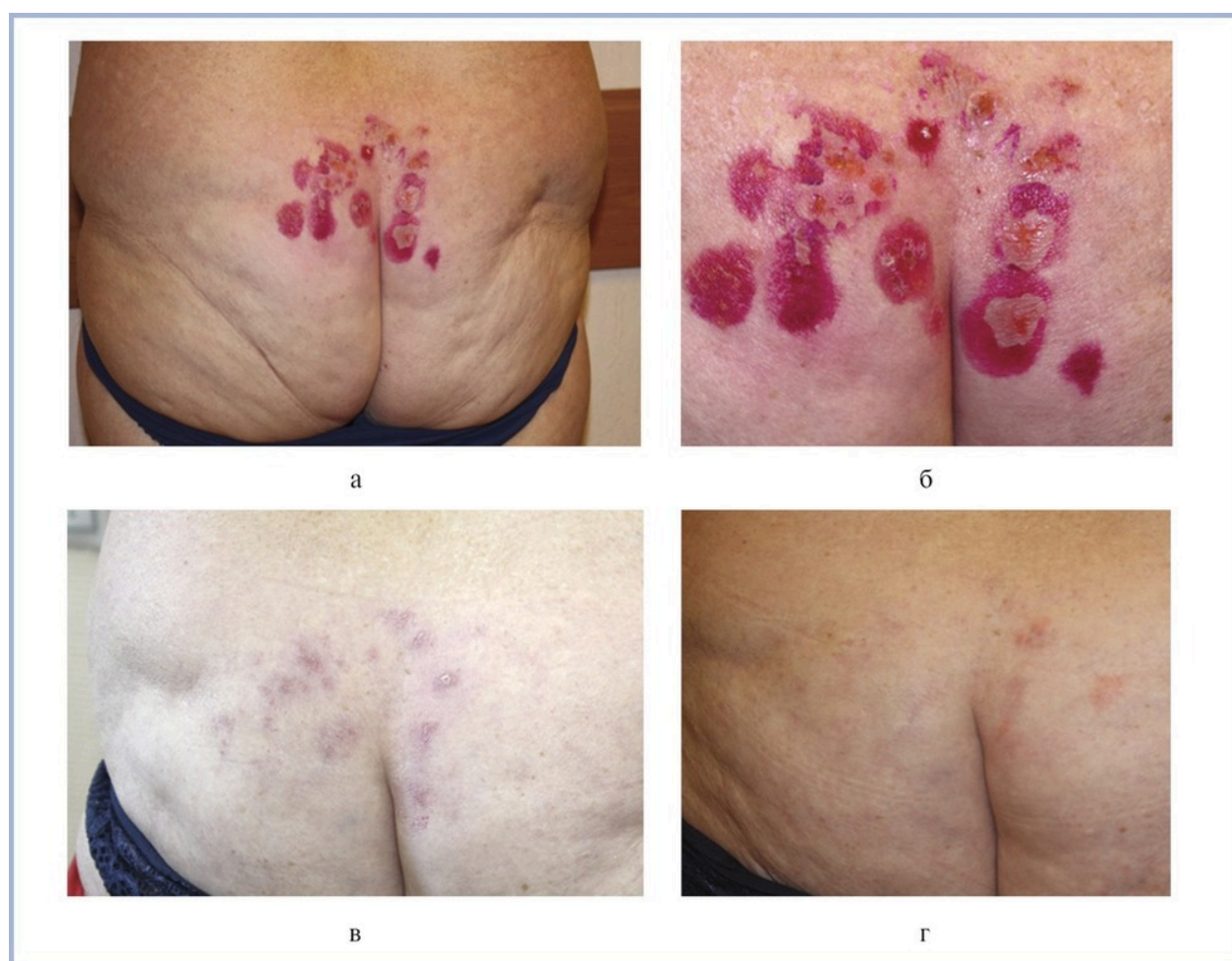


Рис. 1. Рецидивирующий простой герпес у больной С., 60 лет. До лечения — а, б и после лечения — в, г.



После постановки диагноза пациентке было проведено лечение препаратом Фамвир в дозе 500 мг ежедневно в течение 21 дня. Женщина отмечала регулярное появление единичных пузырьков и выраженную болезненность. Больной был назначен 7-дневный курс лечения препаратом *Валвир* в суточной дозе 1000 мг. После терапии отмечен полный регресс высыпаний, отсутствие ПГН.

Больная *Н.*, 69 лет, с диагнозом: опоясывающий герпес (рис. 3). Дебют заболевания произошел на фоне ОРВИ, отита правого уха (сохранялся субфебрилитет). Лечение препаратом Валвир (по 1000 мг 3 раза в день) было начато на 3-й день и продолжалось 7 дней.

Больная *К.*, 58 лет, с диагнозом: опоясывающий герпес (см. рис. 4). Пациентка страдает хроническим лимфолейкозом. Лечение препаратом *Валвир* (по 1000 мг 3 раза в день) по поводу ОГ было начато на 7-й день от первых признаков заболевания и продолжено в течение 7 дней. Отрицательной динамики в общем состоянии и показателях гемограммы не отмечалось.

Заключение

Тяжелые и рецидивирующие формы ГВИ кожи распространены и часто встречаются в практике дерматолога.

Частые рецидивы заболевания значимо влияют на качество жизни пациентов, требуют обоснованной патогенетической противовирусной терапии.

Препарат валацикловир (*Валвир*) является особой транспортной формой ацикловира, содержит L-валин и лучше усваивается в желудочно-кишечном тракте, чем ацикловир.

Валацикловир (*Валвир*) блокирует размножение вируса, предотвращая появление новых герпетических высыпаний на коже.

Апробированы дифференцированные схемы терапии заболеваний кожи, вызванных ВПГ-1 и ВПГ-2 и *Varicella zoster*, препаратом валацикловира (*Валвир*), в том числе терапии в течение 1 дня. Собственные клинические наблюдения свидетельствуют о хорошей клинической эффективности и переносимости препарата *Валвир* в терапии различных форм герпес-вирусных инфекций.



ИЗДАТЕЛЬСТВО
МЕДИА СФЕРА



Наши журналы на **Яндекс Маркет**
Доставка курьером и в пункты выдачи



RU



[Подписка](#)

[Архив](#)

[Книги](#)

[Реклама](#)

[Доставка / Оплата](#)

[О нас](#)

[Контакты](#)

[Политика](#)

[конфиденциальности](#)

[Политика обработки](#)

[персональных данных](#)

[Обучение для редакций](#)

[Регистрация](#)

Телефон

+7 (495) 482-4118

+7 (495) 482-4329

+8 800 250-18-12

(бесплатный номер
по вопросам подписки)
пн-пт с 10 до 18

Почтовый адрес

Издательство «Медиа Сфера»
а/я 54, Москва, Россия,
127238

Электронная почта

info@mediasphera.ru

© 1998-2026